内科含诊断 肝硬化 ★★★（0~6题）

中老年乙 / 丙 / 酒精肝等病史，蜘蛛痣、脾大、侧枝循环、腹水

可能可能最可能

病理

- 肝脏体积（2008、2012、2016）
  - 早期 / 代偿期可正常或稍增大、后期 / 失代偿期多变小
  - 坏死后性肝硬化早期缩小
  - 酒精 / 胆汁 / 淤血 / 血吸虫性肝硬化可增大
- 诊断金标准：穿刺活检见假小叶

饮食

- 代偿期高蛋白、失代偿期低蛋白、并发肝性脑病急性期禁蛋白
- 补充支链氨基酸：减少假性递质
- 补充谷氨酰胺：保护肠粘膜防止细菌和毒素移位

门脉高压

- 脾淤血肿大（最早 / 代偿期可有，2024）
- 脾功能亢进：先 Plt ↓、后 Plt 和 WBC ↓、严重者全血细胞↓
- 最特征 / 价值：侧支循环（2009、2012、2013）
  - ①食管胃底静脉曲张（最主要）：胃镜
  - ②直肠静脉曲张（痔）
  - ③腹壁静脉曲张：海蛇头（脐以上向上 + 脐以下向下）、静脉连续潺潺 / 嘤嘤音
  - ④腹膜后 Retzius 静脉曲张
  - ⑤脾肾分流
- 胃肠淤血和水肿

消化吸收不良、营养不良
出血、贫血、水肿、腹水
电解质紊乱、感染、胆石症
肝性脑病、肝肾 / 肺综合征

肝功减退

- 低白 / 清蛋白血症：白球比倒置、水肿从下肢开始自下而上发展（2017）
- 出血和贫血：凝血因子合成↓（主要）、脾亢致血小板↓、毛细血管脆性↑
- 肝细胞性黄疸（2021）
  - CB ↑＞ UCB ↑、CB/TB 约 0.2~0.5、尿胆红素 +（尿深）、尿胆素原不定
- 不规则低热
- 雌激素灭活减弱（2008、2023）
  - 月经失调、睾丸萎缩、乳房发育、蜘蛛痣和肝掌（毛细血管扩张）、胆石症
- 增高的激素：雌激素、抗利尿激素、醛固酮、胰岛素、胰高血糖素、促黑素（肝病面容）
- 降低的激素：雄激素、CRH、ACTH、糖皮质激素、甲状腺激素“假男人肾上腺皮质功能减退”